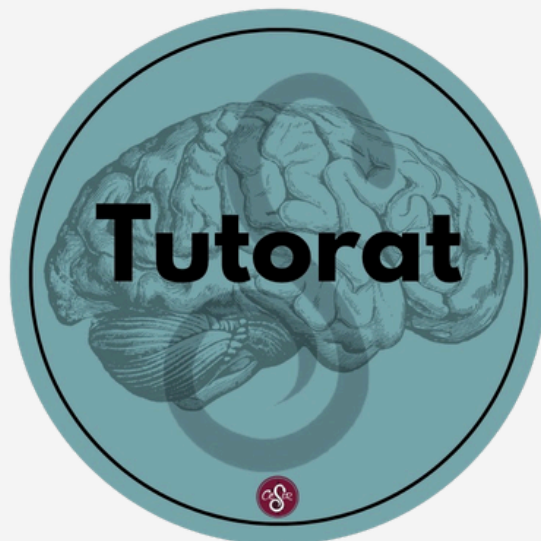


Les troubles de l'humeur

La dépression



La dépression

Episode dépressif caractérisé: phase aiguë
>2 semaines

Altération du fonctionnement social, professionnel...
N'est pas lié à des toxiques/causes somatiques

Complications:

- **Idées suicidaires, tentatives de suicide**
- **Délire congruent à l'humeur**
- **Addictions**
- **Récidive**
- **Evolution vers un trouble chronique de l'humeur**



La dépression

Les symptômes

- ✿ **Tristesse intense**
- ✿ **Anhédonie**: perte de sensation de plaisir
- ✿ **Aboulie**: perte d'initiative, absence d'envie
- ✿ **Perte de l'élan vital**
- ✿ **Anesthésie affective/irritabilité/labilité émotionnelle**
- ✿ **Asthénie** (fatigue)
- ✿ **Ralentissement psychomoteur**
- ✿ **Réveil précoce, anorexie, baisse de la libido**
- ✿ **Anxiété**
- ✿ **Repli**



Moral=thymie

La dépression mélancolique

Forme **la plus sévère** de la dépression

Risque suicidaire

Aréactivité aux stimuli agréables

Fréquente dans les troubles bipolaires

La catatonie

Causée par une mélancolie, des toxiques ou des pathologies neurologiques

Négativisme: opposition à toute proposition

Passivité

Syndrome moteur: perte d'initiative motrice, raideur généralisée, résistance

Pronostic vital engagé: dénutrition, déshydratation

Symptôme très rare



La dépression

Prise en charge

Dépistage d'un potentiel **trouble bipolaire sous-jacent**

Evaluation du risque suicidaire

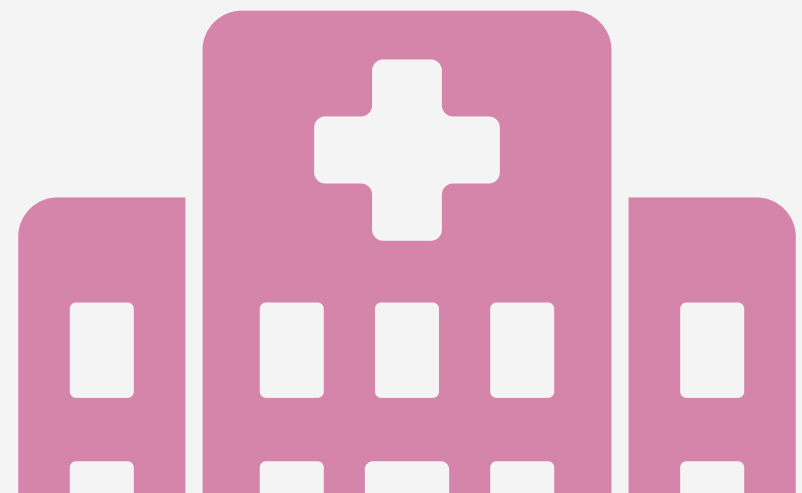
Recueil des antécédents familiaux et personnels

En ambulatoire, CMP, SPAO, urgences, hôpital,
prison...

Hospitalisation si risque suicidaire

Bilan initial à l'entrée (biologique, ECG, toxiques urinaires...), permet d'évaluer **le rôle des toxiques dans la dépression**, d'avoir des valeurs biologiques de références avant l'instauration d'un traitement

Sevrage si OH



La dépression

Prise en charge

Psychologique: psychothérapie de soutien & psychoéducation
(systématique)

Traitements médicaux:

Antidépresseurs: délai d'action 2-4 semaines

Régulateurs de l'humeur (si bipolarité)

Traitements transitoires: anxiolytiques, benzodiazépines et
hypnotiques

Surveiller l'efficacité et les effets indésirables (levée d'inhibition
pour les antidépresseurs)

Si résistance aux traitements médicamenteux:

Electro-convulsivothérapie (ECT): électrochocs 2 à 3
fois/semaine

Prise en charge des aidants



La dépression

Epidémiologie

~20% de la vie entière

2 fois plus fréquents chez les femmes

Traitements efficaces: 70% des cas

Evolution vers une chronicité: 20% des cas

Tentatives de suicides: 5-20% des cas

Touche 1 personne sur 5 au cours d'une vie

